Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004649-41.2022.8.21.0017/RS

AUTOR: GILBERTO EDIMIR BECKER

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS

SENTENÇA

Vistos.

GILBERTO EDIMIR BECKER, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em face de **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS - IPÊ SAÚDE** narrando que é portador de neoplasia maligna de esôfago distal e junção de esôfago gástrica, - CIDC15.5 -, conforme diagnóstico do Dr. Antonio Dal Pizzol Jr, médico que lhe assiste, e necessita fazer uso do fármaco **Nivolumabe (OPDIVO) 240 mg**, conforme orientação médica. Salientou que tem que dar continuidade ao tratamento através das sessões de quimioterapia conjugadas com o uso de Nivolumabe (OPDIVO), eis que a indicação de tal associação de recursos possui vistas ao aumento da sobrevida global e maior taxa de resposta se comparado ao tratamento quimioterápico isolado. Asseverou que a prescrição médica para o caso prevê o tratamento conjugado por tempo indeterminado, salvo progressão da doença ou toxidade limitante. Argumentou que ao proceder com a solicitação de autorização junto ao réu do referido fármaco, foi negado em 05/04/2022, sob a alegação de que este tratamento não está previsto nas recomendações técnicas. Postulou a concessão da tutela de urgência, no sentido de que a demandada seja compelida a fornecer a medicação. Ao final, requereu a confirmação da tutela, determinando que o réu proceda a autorização devida. Pleiteou a concessão da AJG. Atribuiu à causa o valor de alçada.

Deferida a antecipação de tutela e a AJG (evento 3).

Citada, a parte ré contestou (evento 13). Narrou que possui protocolo oncológico elaborado pela Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, o qual prevê quais medidas devem ser utilizadas em cada neoplasia, nos diferentes estágios e tratamentos. Aduziu que o fornecimento do medicamento postulado não faz parte das Recomendações Técnicas para tratamento oncológico adotadas pela autarquia. Salientou, entretanto, que admitir que esteja o demandado obrigado a fornecer todo e qualquer serviço aos seus segurados e dependentes, sem limitação e fora das situações previstas, significaria ignorar os princípios da legalidade e igualdade a que se sujeita o administrador público na prestação do serviço estatal. Salientou a inaplicabilidade do CDC. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Sobreveio réplica (evento 16).

Instadas acerca das provas a produzir, requereram as partes o julgamento antecipado da lide (eventos 22 e 24).

Sem mais, vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relato. **DECIDO.**

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que requer a parte autora seja determinada à requerida fornecer o tratamento indicado para a moléstia que lhe acomete (neoplasia maligna de esôfago distal e junção de esôfago gástrica, - CIDC15.5).

Não há controvérsia acerca da contratação do plano de saúde, de ser a parte autora portadora da moléstia mencionada, sendo que, segundo o médico assistente da autora, conforme laudo médico (laudo 8):

COMPLEXO HOSPITALAR
Porto Alegre
HOSPITAL SANTA RITA
Excelência pela vida

Laudo Médico

Atesto que GILBERTO EDIMIR BECKER possui diagnóstico de patologia CID C15.5 – neoplasia maligna de esôfago distal e junção esôfago gástrica previamente tratada com quimioterapia e radioterapia, seguidos de cirurgia.

Em exames de reavaliação sistêmica de janeiro de 2022 foi evidenciado recidiva peritoneal e linfonodal em região cervical. Paciente submetido a biópsia de ambos os sítios que confirmou recidiva de adenocarcinoma.

Iniciou tratamento quimioterápico com esquema FOLFOX, com ótima tolerância. Paciente tem indicação do acréscimo de Nivolumabe (OPDIVO®) ao esquema quimioterápico, visto tal combinação demonstrar aumento de sobrevida global e maior taxa de resposta quando comparado ao esquema quimioterápico isolado. Tal associação (FOLFOX e Nivolumabe) deve ser mantida por tempo indeterminado, até progressão de doença ou toxicidade limitante.

O uso da medicação citada nesse contexto clínico é amparado por consensos técnicos de reconhecimento internacional como o NCCN (nccn.org) e possui aprovação em bula para uso no Brasil.

O perfil de tolerabilidade é compatível com a condição clínica apresentada pelo paciente. O paciente será submetido a avaliações clínicas, laboratoriais e radiológicas em caráter periódico, sendo a droga mantida enquanto a relação entre benefício clínico e toxicidade se mantiver favorável.

Dado o exposto, ratifica-se a indicação de início de tratamento com a medicação Nivolumabe(OPDIVO®) nesse paciente, o mais breve possível, sem interrupções não programadas e associadas com a manutenção do acompanhamento oncológico vigente.

A referência para uso é baseada nos dados do estudo CHECKMATE-649 e pode ser acessado em : [Lancet 398:27, 2021]

Porto Alegre, 27 de abril de 2022.

Antonio Dal Pizzol Jr.
Oncologia Clínica
CREMERS 25140

Antonio Dal Pizzol Jr.
Oncologia Clínica
CREMERS 25140

Destarte, corroborando a urgência do caso.

Discute-se nos autos se faz *jus* a parte autora ao tratamento prescrito, eis que, conforme a ré, não estaria previsto sua dispensação no contrato na forma postulada.

Ab initio, sinalo que o caso em testilha não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata a ré de entidade de autogestão. Nesse sentido, editada a Súmula 608 pelo STJ, com o seguinte teor: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,* ***salvo os administrados por entidades de autogestão****." - grifei.*

Convém ressaltar o entendimento - já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - de que *'a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato*' (REsp 183.719/SP).

Da mesma forma, é assente o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007).

Seguindo essa linha de raciocínio, é decorrência lógica considerar que o rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde.

Em casos similares, assim já decidiu o TJRS:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PEMBROLIZUMABE. O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade oncologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do IPE-SAÚDE, do medicamento indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento da moléstia que acomete a parte, Neoplasia Maligna de Cólon. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70085531044, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 02-03-2022)

Apelação Cível, Nº 70082957416, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 28-11-2019. Apelação Cível. Plano de saúde. Recusa de autorização para do medicamento medicamento Pemetrexed (Aliantra). Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento firmado no julgamento do REsp 1285483 e Súmula 608 do STJ. Recusa

da operadora ao argumento de que a medicação é off label e não está prevista no rol de procedimentos da ANS. Indicação médica. Doença para a qual há cobertura contratual. Cobertura devida. Indicação do tratamento adequado cabe ao médico especialista. Apelo desprovido.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais abusivas que imponham restrições ou limitações de sessões ou procedimentos médicos que afetem de maneira significativa a própria essência do contrato podem ser revisadas, desde que haja cobertura para as doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, bem como prescrição do médico que declare a imprescindibilidade do tratamento.

A título exemplificativo:

AgInt no RESP. nº 1.349.647/RJ, Relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 23/11/2018 -*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.* ***3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia****. 5. Agravo interno não provido.*

Ora, nestes termos, é inconcebível que a requerida tenha negado a cobertura ao tratamento prescrito à autora, indispensável para o controle da doença que acomete a mesma, nos termos da Lei n. 9.656/1998, artigo 12, inciso I, alínea 'd' – Procedimento incorporado às coberturas mínimas, *in verbis*:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) *cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;*

b) *cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;*

c) *cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*

Ainda, impende sinalar que os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar n° 12.132/04, aduzem que:

"Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde.".

No caso em apreço, restou comprovado que o tratamento postulado se mostra imprescindível para o tratamento da doença que acomete o consumidor, conforme atestado médico e documentos acostados à inicial.

Resta extreme de dúvidas que a doença se afigura grave e a não realização do tratamento adequado acarreta riscos à saúde da parte autora.

Desta forma, afigura-se indevida a recusa da operadora.

Existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

A restrição de cobertura a determinadas enfermidades ou tratamentos é abusiva, por exonerar o prestador de serviços da obrigação de assumir os riscos referentes à necessidade futura de assistência médico hospitalar, dever que é inerente à finalidade do contrato.

Destarte, é dever do demandado em fornecer o tratamento pleiteado, sendo a procedência da demanda medida que se impõe.

Dispositivo.

Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GILBERTO EDIMIR BECKER** em face de **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS - IPÊ SAÚDE,** para confirmar a antecipação de tutela deferida (evento 3), que determinava à requerida que autorize e custeie o tratamento, disponibilizando o fármaco Nivolumabe (OPDIVO) 240 mg ao autor, conforme orientação médica, nos termos da inicial.

Por sucumbente, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista o trabalho do profissional, o tempo de duração da demanda e o julgamento antecipado da lide.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias. Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO GILBERTO MARRONI VITOLA, Pretor**, em 6/12/2022, às 5:42:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10029792295v3** e o código CRC **5d1a4363**.